

► Sémiologie Clinique

1/ - Cochez la ou les réponses justes :

- A- Une langue recouverte de papilles, humide et rosée ou rouge est normale
- B- Lors de l'examen du plancher de la bouche, La muqueuse de la face inférieure de la langue est normalement sèche et pâle.
- C- L'examen doit commencer par la zone douloureuse afin de mieux localiser la douleur.
- D- Lors de l'examen clinique, les vergetures peuvent être blanchâtres après un amaigrissement important ou une grossesse, et roses violacées en cas d'hypercorticisme.
- E- Toutes les réponses sont justes

2/ Concernant la diarrhée, quelle(s) proposition(s) est/sont exacte(s) ?

- A. La dysenterie est définie par la présence de sang dans les selles, associée obligatoirement à plus de 3 selles/jour
- B. Une diarrhée persistante correspond à une diarrhée évoluant depuis au moins 14 jours.
- C. Les deux types de diarrhée aiguë sont : inflammatoires et sécrétoires.
- D. Les antibiotiques induisent une diarrhée aiguë sans altération du microbiote colique
- E. Toutes les réponses sont justes

3/ Cochez la ou les réponses justes : concernant la diarrhée aiguë :

- A. Une diarrhée survenant immédiatement après un repas avec urticaire et œdème de la face peut évoquer une origine allergique.
- B. Une diarrhée aqueuse avec douleurs abdominales modérées oriente plutôt vers un mécanisme inflammatoire.
- C. La présence d'un érythème noueux ou d'une arthrite réactionnelle peut être observée lors d'infections à Campylobacter ou Yersinia.
- D. Les hémocultures doivent être réalisées systématiquement devant toute diarrhée aiguë, même sans fièvre.
- E. aucune réponse n'est juste

4/ Les complications de la diarrhée aiguë :

- A. Déshydratation de type isotonique, hypertonique ou hypotonique selon l'importance et la nature des pertes.
- B. Acidose métabolique par perte de bicarbonates.
- C. Risque de malnutrition, retard staturo-pondéral, décès dans les formes sévères
- D. Hypokaliémie
- E. Aucune réponse n'est juste

5/ Quelles sont les caractéristiques sémiologiques des douleurs abdominales pancréatiques ?

- a) Douleurs intenses à type de colique
- b) Début brutal comme « un coup de tonnerre dans un ciel serein »
- c) Le patient décrit une douleur en coup de poignard
- d) Irradiation dorsale transfixiante
- e) La position penchée en avant exacerbe la douleur

6/ Concernant la dysphagie, quelles sont les propositions justes ?

- a) C'est un obstacle à la progression du bol alimentaire
- b) La dysphagie est systématiquement d'origine organique
- c) Une aphagie est un obstacle total aux aliments solides et liquides
- d) La sténose peptique est l'une des causes de la dysphagie
- e) Les anomalies primitives de la motricité sont retrouvées chez les enfants

7/ Quelles sont les diagnostics différentiels à évoquer devant une dysphagie

- a) L'odynophagie
- b) Le globus hystericus
- c) Le merycisme
- d) L'éructation
- e) L'anorexie

8/ Quels sont les éléments à rechercher lors de l'examen clinique devant une dysphagie ?

- a) Évaluer l'état nutritionnel
- b) Rechercher une déshydratation
- c) Rechercher une adénopathie
- d) Mesure de la flèche hépatique
- e) Un examen ORL à la recherche d'une tumeur du pharynx

9/Concernant l'ictère quelles sont les propositions justes ?

- a) Le subictère témoigne d'un taux de bilirubinémie < 10 mg/dl
- b) L'ictère doit être recherché au niveau des lèvres et pavillon des oreilles
- c) L'ictère s'accompagne d'urines mousseuses par élimination des sels biliaires
- d) Les selles sont décolorées en cas d'ictère à bilirubine conjuguée
- e) L'ictère s'accompagne d'un excès en vitamines liposolubles

10 Quelles sont les éléments retrouvés en cas d'ictère à bilirubine conjuguée ?

- a) Une hémolyse chronique
- b) Des urines foncées
- c) Un bilan hépatique perturbé
- d) Un déficit enzymatique en G6PD
- e) C'est un ictère bronze florentin

11 Parmi les propositions suivantes, quelles sont les causes de l'ictère à bilirubine conjuguée ?

- a) Ictère du nouveau né par immaturité
- b) Ictère cytolytique des hépatites virales
- c) Obstacle sur le cholédoque
- d) La maladie de Gilbert
- e) Le favisme

12 Quels sont les éléments à rechercher dans la démarche étiologique devant une hématurie ?

- a) La prise d'AINS ou d'Aspirine
- b) Une intoxication alcoolo-tabagique
- c) Un antécédent d'ulcère gastrique
- d) Des signes d'hypertension portale
- e) La notion de prise de la température rectale

13 Parmi les pathologies suivantes, quelles sont les causes des hématuries ?

- a) Un cancer du cardia
- b) Une colite ulcéro-hémorragique
- c) Une amibiase
- d) Une œsophagite peptique
- e) Une sigmoïdite diverticulaire

14 Concernant les vomissements, quelles sont les propositions justes ?

- a) La nausée est un équivalent des vomissements
- b) Les vomissements sont toujours d'origine digestive
- c) Les vomissements fécaloïdes sont observés en cas d'angiocholite
- d) Les stimuli peuvent être chimiques ou des émotions
- e) Aucune réponse juste

15 Quelles données anamnestiques sont à rechercher devant des vomissements ?

- a) Date du début des vomissements : aigus subaigus ou chronique
- b) Horaire en fonction des repas
- c) Notion d'efforts, les vomissements faciles en jet sont d'origine neurologique
- d) La notion d'arrêt des matières et des gaz
- e) La notion de prise médicamenteuse (chimiothérapie)

16 Parmi les propositions suivantes, quelles sont les causes de vomissements aigus ?

- a) Gastro-entérite aigue
- b) Le syndrome de Ménière
- c) La sténose du pylore
- d) La gastroparésie diabétique
- e) Le malaise vagal

17 Concernant la classification de Hambourg des péritonites (P), quelles sont les propositions exactes ?

- a- La contamination péritonéale au cours des P. primitives se fait souvent par voie hématogène.
- b- L'infection du liquide d'ascite chez le cirrhotique est la forme la plus fréquente des P. primitive.
- c- Le traitement des P. primitives est essentiellement chirurgical.
- d- Les P. secondaires sont caractérisées par une infection mono-bactérienne.
- e- Les P. tertiaires se définissent par une persistance de l'infection malgré un traitement initial bien conduit

18) Lors de l'examen physique d'un syndrome péritonéal typique, que peut-on observer ?

- a- Un abdomen mobile qui suit les mouvements respiratoires.
- b- Une contracture abdominale définie comme une rigidité involontaire, permanente et invincible.

- c La contracture abdominale peut être remplacée par une défense généralisée.
- d- Un toucher rectal non douloureux.
- e- Un tympanisme pré-hépatique à la percussion, en cas de pneumopéritoine.

19) A propos de la péritonite par perforation d'un ulcère gastroduodénal :

- a- La douleur initiale est classiquement décrite comme un coup de poignard.
- b- Elle s'accompagne souvent d'une fièvre dès le début.
- c- Le siège initial de la douleur est le plus souvent la fosse iliaque droite.
- d- La prise d'AINS est un facteur favorisant.
- e- Le pneumopéritoine observé au scanner est souvent volumineux et de localisation sus-mésocolique.

20/ Parmi les propositions suivantes concernant l'examen clinique du foie, laquelle (lesquelles) est (sont) juste(s) :

- A. La percussion hépatique permet principalement de délimiter le bord supérieur du foie.
- B. Lors de la palpation hépatique, l'examineur se place habituellement à gauche du malade.
- C. Chez l'adulte, la flèche hépatique normale est de 10 à 12 cm.
- D. Chez le sujet normal en règle, le bord inférieur du foie déborde le rebord costal, sauf chez le sujet longiligne.
- E. Le bord inférieur du foie est régulier, dur, épais et mobile lors des mouvements respiratoires.

21/ Parmi les propositions suivantes concernant l'examen clinique du foie, laquelle (lesquelles) est (sont) juste(s) :

- A. La méthode de Chauffard est une technique de palpation bimanuelle
- B. La méthode de Gilbert est une technique de palpation bimanuelle
- C. Lors de la Méthode de Mathieu l'examineur se place à la tête du malade
- D. La méthode de Gilbert utilise la technique des doigts en crochet pour percevoir le bord inférieur du foie à l'inspiration
- E. Aucune réponse n'est juste

22/ l'hépatomégalie vasculaire se caractérise par (cochez la ou les réponses justes) :

- A. Une surface lisse
- B. Un bord inférieur tranchant
- C. L'absence des signes accompagnateurs
- D. L'absence de douleur
- E. La prédominance sur un lobe

23/ Parmi les propositions suivantes concernant l'ascite, laquelle (lesquelles) est (sont) correcte(s) ?

- A. L'hémopéritoine et les péritonites purulentes sont des formes particulières de l'ascite
- B. L'ascite chyleuse se caractérise par un aspect limpide et transparent
- C. L'ascite cloisonnée est due à des adhérences soudant en partie le feuillet viscéral et le feuillet pariétal
- D. Les ascites d'origine inflammatoire sont principalement liées à une défaillance de la pompe cardiaque
- E. Les ascites d'origine inflammatoire peuvent être secondaires à une augmentation de la pression dans le système porte

24/ Concernant les diagnostics différentiels de l'ascite, quelles sont les propositions justes ?

- A. Une adiposité pariétale importante peut rendre difficile le diagnostic d'une ascite de faible abondance.
- B. Un globe vésical donne une matité sous-ombilicale à limite supérieure convexe vers le haut.
- C. Un kyste ovarien à développement abdominal peut réaliser une matité médiane ou latéralisée à limite supérieure convexe vers le haut.
Un gros rein
- E. Aucune réponse n'est juste

25/ Cochez la ou les causes des ascites inflammatoires sont :

- A. Le syndrome de Demons MEIGS
- B. Le syndrome néphrotique
- C. La cirrhose
- D. L'ascite tuberculeuse
- E. L'ascite cancéreuse

26/ Un patient de 70 ans se présente pour des douleurs abdominales d'apparition progressive, un météorisme important et un arrêt des matières et des gaz précoce. Les vomissements sont apparus tardivement. Quel est le diagnostic le plus probable ?

- A. Une occlusion du grêle par strangulation sur bride.
- B. Une occlusion colique par obstruction tumorale.
- C. Abscès splénique.
- D. Abscès hépatique.
- E. Une appendicite.

27/Devant une masse de l'hypochondre gauche, le diagnostic différentiel d'une splénomégalie comprend :

- A. Un gros rein gauche.
- B. Une tumeur de la queue du pancréas.
- C. Une tumeur de l'angle colique gauche.
- D. Une tumeur de la surrénale gauche.
- E. Un gros rein droit.

28/Parmi les complications possibles de la splénomégalie :

- A. Infarctus splénique.
- B. Rupture splénique.
- C. Hypersplénisme.
- D. Polyglobulie constante.
- E. Pancytopénie.

29/ Concernant la splénomégalie, quelle(s) affirmation(s) est/sont correcte(s) ?

- A. Une rate est considérée comme hypertrophiée si elle dépasse 8 cm à l'échographie
- B. Elle est diagnostiquée seulement par l'échographie
- C. Une rate est considérée comme hypertrophiée si elle dépasse 14 cm à l'échographie.
- D. La splénomégalie peut être découverte de façon fortuite.
- E. Elle est diagnostiquée seulement par l'examen clinique

30) Le bilan de 2^{ème} intention pour l'exploration d'une constipation chronique, comprend essentiellement :

- A - La mesure du temps de transit colique
- B - La rectocolonoscopie
- C - La défécographie
- D - La manométrie anorectale.
- E - Il est demandé notamment si une constipation fonctionnelle est suspectée

31 Quels signes peuvent être retrouvés dans l'hépatite alcoolique,

- A - Une érythrose palmaire
- B - Un érythème noueux
- C - Un hippocratisme digital
- D - Une macrocytose,
- E - Une élévation des γ -GT

32-Sur le plan sémiologique, quelle caractéristique clinique permet de suspecter une anomalie de coagulation plutôt qu'une anomalie de l'hémostase primaire ?

- A. la présence de bulles hémorragiques
- B. des hémorragies profondes (hémarthroses)
- C. des ecchymoses multiples
- D. un purpura sénile
- E. des lésions erythemato-squameuses

33-Un jeune garçon présente des hémarthroses à répétition au niveau des genoux et des coudes

Le bilan biologique montre un taux de plaquette normal, un TP normal, mais un TCA très allongé,

Quel diagnostic devez-vous évoquer en priorité ?

- A. Un purpura rhumatoïde
- B. Une insuffisance hépatocellulaire sévère
- C. Une endocardite infectieuse
- D. Un trouble de l'hémostase primaire
- E. Une hémophilie constitutionnelle

34-Concernant les caractéristiques générales des adénopathies, quelle(s) proposition(s) est(sont) exacte(s) ?

- a- Une adénopathie est définie comme un ganglion lymphatique à diamètre supérieur à 1 cm, quel que soit le territoire
- b- Les ganglions lymphatiques sont des organes lymphoïdes primaires.
- c- Les ganglions lymphatiques sont des organes lymphoïdes secondaires
- d- Le diagnostic positif d'une adénopathie est souvent difficile.
- e- Une adénopathie est dite chronique si sa durée d'évolution est supérieure à trois semaines.

35- Concernant les diagnostics différentiels des adénopathies, lesquels sont corrects ?

- a- En région cervicale médiane, un kyste du tractus thyroïdien peut simuler une adénopathie.
- b En région axillaire, une hidrosadénite peut simuler une adénopathie.
- c En région inguinale, une hernie peut être confondue avec une adénopathie.
- d Une hypertrophie de la glande sous-maxillaire constitue un diagnostic différentiel en région inguinale.

e- Un lipome ne pose pas de problème de diagnostic différentiel avec un ganglion.

36- Concernant le ganglion de Troisier :

- a- Il siège dans le creux axillaire gauche.
- b Il siège dans le creux sus-claviculaire gauche.
- c- Sa découverte impose une exploration rigoureuse de l'étage sous-diaphragmatique.
- d- Il s'agit d'adénopathie ferme ou dure, fixée au plan profond s'il est d'origine cancéreuse.
- e- Sa présence est considérée comme un signe certain de tuberculose ganglionnaire.

37-Concernant l'hémogramme (FNS) :

- A C'est l'examen le plus prescrit en hématologie
- B. A pour but d'apporter des informations quantitatives et qualitatives sur les cellules sanguines
- C. A pour but d'apporter des informations quantitatives des cellules de la moelle osseuse
- D Réalisé sur un tube contenant un anticoagulant sec de type EDTA
- E. Réalisé sur tube sec

38-A propos des anémies hypochromes microcytaires, cochez les réponses justes:

- ☒ A. Définies par une diminution du CCMH $< 32\%$ avec diminution du VGM < 80 fl.
- ☒ B. Dues aux anomalies de synthèse de l'Hb: β thalassémie
- C. Dues à une Carence martiale par malabsorption digestive
- D. Résultent principalement d'un déficit en érythropoïétine
- E Résultent d'une destruction prématurée et excessive des globules rouges

39-Au cours des anémies macrocytaires on note :

- A. Un taux Hb bas + VGM > 100 fl
- B. Un taux de CCMH bas + VGM > 100 fl
- C. Le Bilan martial est normal ou légèrement diminué
- D La carence vitaminique est la cause la plus fréquente : vit B12
- E. Peuvent être rencontrées Au cours d'hépatopathies

40- Concernant la Neutropénie :

- A. Est définie par une diminution du taux des polynucléaires neutrophiles (PNN) $< 1700/\text{mm}^3$
- ☒ B. Est définie par une diminution du taux des polynucléaires neutrophiles (PNN) $< 1\ 000/\text{mm}^3$.
- C. Cause fréquente des infections virales
- D. Cause fréquente des syndromes lymphoprolifératifs
- E- Une neutropénie sévère est définie par un taux de PNN $< 500/\text{mm}^3$

► Physiopathologie

41-L'hémorragie digestive basse peut être due à :

- A Ulcère gastrique
- B. Diverticule colique
- C. Hémorroïdes
- D. Varices œsophagiennes
- E. Une anémie

42-L'angiodysplasie se caractérise par :

- A. Vaisseaux fragiles
- B. Saignement intermittent
- C. Origine tumorale
- D. Liée à l'âge
- E. Une thrombose

43-Au cours de la fibrinolyse on retrouve :

- A. Un TP augmenté.
- B. Un taux de D Dimères élevé.
- C. Un taux de plaquettes bas.
- ☒ D. Un taux de fibrinogène bas.
- E. Aucune réponse n'est juste.

44-Dans la CIVD (coagulation intra vasculaire disséminée) on retrouve :

- A. Un taux de D Dimères bas.
- B Un taux de D Dimères élevé.

- C. Un TP bas.
- D. Un taux de fibrinogène élevé.
- E. Un taux de plaquettes normal.

45-L'ictère à bilirubine conjuguée peut être du à:

- A. Déficit congénital en glucuronyl transférase.
- B. Trouble de la captation.
- C. Obstacle intra-hépatique.
- D. Tumeur de la tête du Pancréas.
- E. Hépatites virales.

46-Le diagnostic d'un ictère cholestatique est posé devant :

- A. Bilirubine libre augmentée.
- B. Obstacle extra-hépatique.
- C. Bilirubine conjuguée normale.
- D. Selles décolorées.
- E. Hémolyse auto-immune.

47-Dans l'ictère néonatal :

- A. La bilirubine conjuguée est augmentée.
- B. La bilirubine libre est diminuée.
- C. Les urines claires.
- D. L'inhibition est transitoire en glucuronyl-trasférase.
- E. L'hémolyse est physiologique.

48-Au cours de la cirrhose, l'augmentation du gradient de pression porto-cave résulte de deux mécanismes principaux. Lesquels ?

- A. Une diminution du flux portal associée à une vasodilatation intrahépatique.
- B. Une augmentation du flux portal associée à une diminution des résistances intrahépatiques.
- C. Une augmentation du flux portal (phénomène splanchnique) et une augmentation des résistances intrahépatiques par la fibrose et la vasoconstriction.
- D. Une thrombose de la veine cave inférieure et une fistule artério-veineuse hépatique.
- E. Une augmentation isolée du débit cardiaque.

49-Parmi les conséquences hémodynamiques et systémiques de l'Hypertension portale, une proposition est FAUSSE laquelle?

- A. Elle entraîne la formation d'un syndrome hyperkinétique avec augmentation du débit cardiaque.
- ✓ B. Elle favorise la formation de varices œsophagiennes par développement de shunts porto-systémiques.
- ✗ C. Elle provoque une vasoconstriction splénique responsable d'une diminution du volume de la rate.
- D. Elle participe, en association avec l'insuffisance hépatocellulaire, à la formation d'ascite.
- ✓ E. Elle est responsable du shunt de toxines digestives vers la circulation générale, pouvant causer une encéphalopathie hépatique.

50-A quoi est liée l'occlusion intestinale aiguë d'origine fonctionnelle

- A. Obstacle
- ✓ B. Arrêt du péristaltisme intestinal
- C. Sténose intestinale
- D. Stase gastrique
- E. Colique nephretique

51-Au cours d'une occlusion intestinale, la distension intestinale est :

- A. En aval de l'occlusion
- B. En amont de l'occlusion
- C. Liée à la déglutition d'air
- D. Liée à la production du gaz par les bactéries intestinale
- E. Liée à accumulation de liquides digestif

52- Concernant l'effet de l'équilibre acido-basique sur la kaliémie :

- A. Toute acidose provoque une hyperkaliémie importante
- B. L'alcalose favorise l'entrée du potassium dans les cellules
- C. L'alcalose entraîne toujours une hyperkaliémie

q 44D L'acidose lactique entraîne systématiquement une hyperkaliémie sévère

E. Le pH n'influence pas la kaliémie

53- Une hyperosmolarité plasmatique peut entraîner une hyperkaliémie par :

A. Augmentation de l'excrétion rénale du potassium

B. Passage du potassium vers le milieu intracellulaire

C. Sortie d'eau des cellules avec déplacement du potassium vers le secteur extracellulaire

D. Diminution de la sécrétion d'aldostérone

E. Augmentation de la réabsorption tubulaire du potassium

54-Quelle association ECG est la plus évocatrice d'une hypokaliémie ?

A. Onde T pointue + QT court

B. Onde U proéminente + onde T aplatie

C. Sus-décalage ST + onde Q pathologique

D. Microvoltage diffus

E. Bloc de branche gauche

55- L'hypomagnésémie peut être responsable de :

A. Hyporéflexie ostéo-tendineuse

B. Dépression neuromusculaire

C. Hyperexcitabilité neuromusculaire

D. Paralysie flasque constante

E. Diminution de l'automatisme cardiaque

56- L'hypermagnésémie sévère peut entraîner :

A. Tachycardie ventriculaire

B. Hypertension artérielle sévère

C. Hyperthermie

D. Hyperactivité sympathique

E. Bradycardie et troubles de conduction

► Biochimie

57- Parmi les protéines suivantes, laquelle est la plus abondante dans le plasma humain ?

A- Haptoglobine

B- Transferrine

C- Albumine

D- Fibrinogène

E- Orosomucoïde

58- La maladie de Kahler

A. Est une lymphocytose médullaire

B. Est suspectée devant une protidémie très élevée

C. Est une plasmocytose médullaire

D. Est une maladie à chaîne légères

E. Survient essentiellement chez la femme jeune

59- Quel profil électrophorétique est typique du syndrome néphrotique ?

A- Diminution de l'albumine et élévation des alpha-2-globulines

B- Hypergammaglobulinémie monoclonale

C- Diminution globale de toutes les fractions

D- Élévation des bêta-globulines uniquement

E- Un bloc bêta gamma

60- Concernant les cellules pariétales de l'estomac ?

A. Elles sécrètent le pepsinogène.

B. Elles produisent le mucus gastrique.

C. Elles sécrètent l'acide chlorhydrique (HCl)

D. Elles sécrètent la gastrine.

E. Elles produisent la somatostatine.

61-Le test au D-xylose est principalement utilisé pour explorer :

- A. L'absorption de la vitamine B12 au niveau iléal.
- B. Une malabsorption duodéno-jéjunale.
- C. Une insuffisance pancréatique exocrine.
- D. La maladie coéliquaue.
- E. Une cholestase extra-hépatique.

62-La vitamine B12, associée au facteur intrinsèque, est absorbée :

- A- Au niveau de l'estomac
- B- Au niveau du duodénum
- C- Au niveau du jéjunum
- D- Au niveau de l'iléon
- E- Sur toute la longueur du grêle

63-A propos de la bilirubine :

- A. Elle provient de la destruction de l'hémoglobine des globules rouges au niveau de la rate
- B. Elle circule dans le sang sous-forme libre, non liée à l'albumine
- C. Elle subie une conjugaison hépatique sous forme glucuronide
- D. Il s'agit d'un pigment de couleur jaune, photo-oxydable
- E. La bilirubine directe est insoluble et hautement neurotoxique

64-Quelles sont les variations biologiques d'une stéatose hépatique non alcoolique ?

- A- ALT et AST > 25; AST/ALT ≤ 1, GGT normale, ferritinémie très élevée
- B- AST et ALT > 4, AST/ALT ≤ 1, GGT > 2, ferritinémie modérément élevée
- C-AST > 8 fois, ALT > 5, AST/ALT > 1, ferritinémie modérément élevée, GGT > 10
- D-ALT et AST > 10, AST/ALT < 1, ferritinémie normale, GGT > 2
- E- ALT et AST > 50, AST/ALT > 1, GGT normale, ferritinémie très élevée

65-Parmi ces ictères néonataux, lequel est à prédominance de bilirubine conjuguée ?

- A- Ictère physiologique
- B- Maladie de Gilbert
- C- Maladie de Crigler-Najjar
- D- Syndrome de Dubin Johnson
- E- Syndrome de Rotor

66-Parmi les propositions suivantes concernant les oncogènes, quelle est celle qui est exacte ?

- A. Ils dérivent souvent de proto-oncogènes cellulaires normaux.
- B. Leur inactivation favorise la prolifération cellulaire.
- C. Leur effet est toujours récessif.
- D. Ils interviennent uniquement dans la réparation de l'ADN.
- E. Une mutation des deux allèles est nécessaire pour leur activation.

67-A propos des marqueurs tumoraux :

- A- Les cellules tumorales circulantes et l'ADN tumoral circulant sont de nouveaux biomarqueurs sériques du cancer.
- B- Les marqueurs tumoraux sont utilisés uniquement pour le diagnostic initial des cancers.
- C- Le PSA est un marqueur utilisé dans le suivi du cancer de la prostate.
- D- Le marqueur ne reflète jamais la sensibilité de la tumeur à un traitement.
- E- Certains marqueurs tumoraux peuvent être augmentés dans des pathologies bénignes.

68-Parmi les marqueurs suivants, lequel demanderez-vous pour le diagnostic d'un cancer médullaire de la thyroïde :

- A. Calcitonine.
- B. Thyroglobuline.
- C. Alpha-fœtoprotéine (AFP).
- D. ACE (antigène carcino-embryonnaire).
- E. CA15.3.

► Radiologie

69-Dans l'imagerie des urgences abdominales non traumatiques :

- a. L'acquisition scanographique au temps artériel est nécessaire dans les pathologies hémorragiques aiguës
- b. L'acquisition au temps portal est fondamentale
- c. L'IRM a un grand intérêt en pathologie hépato-biliaire

d. Les acquisitions au temps tardif permettent d'explorer l'appareil urinaire

e. L'échographie est souvent utile en dernière intention

70-Dans l'imagerie des urgences abdominales non traumatiques :

a. Le couple ASP- échographie est indiqué dans l'exploration des coliques néphrétiques

b. Le scanner permet d'effectuer le bilan lésionnel et de gravité d'une pancréatite aiguë

c. Le macro abcès hépatique est une lésion hyperdense non circonscrite

d. L'épaississement pariétal et l'épanchement intra-péritonéal sont des signes de souffrance en cas d'occlusion

e. Les niveaux hydro-aériques sont plus larges que hauts en cas d'occlusion du grêle

71-Dans l'imagerie du haut appareil digestif :

a. La radiographie thoracique explore les opacités et les clartés médiastinales

b. La radiographie de l'abdomen sans préparation explore les opacités et clartés médiastinales

c. La baryte peut être utilisée dans le contrôle post-opératoire immédiat

d. La baryte est contre-indiquée en cas de suspicion clinique de perforation digestive

e. Le transit œsophagien en couche mince permet l'étude du plissement muqueux

72-Dans l'imagerie du haut appareil digestif :

a. La sténose bénigne est centrée et régulière

b. La sténose maligne est excentrée et irrégulière

c. La sténose maligne est excentrée et régulière

d. La malrotation est une anomalie fonctionnelle

e. Le spasme et le reflux sont des anomalies fonctionnelles

73-Concernant l'occlusion intestinale aiguë du grêle :

a. Sur l'ASP debout, les niveaux hydro-aériques sont multiples, centraux et plus larges que hauts.

b. Sur l'ASP debout, les niveaux hydro-aériques sont périphériques et plus hauts que larges.

c. La TDM montre une distension colique avec zone de transition.

d. La TDM montre une distension intestinale diffuse colique et grêlique

e. La TDM montre une distension grêlique avec zone de transition..

74-Concernant L'opacification digestive basse :

a. Le sulfate de baryum est communément utilisé (lavement baryté).

b. L'opacification en double contraste consiste à l'infusion de baryte sans insufflation d'air.

c. L'opacification en mono contraste consiste à l'infusion de baryte sans insufflation d'air.

d. Les ulcérations et les diverticules forment des images de soustraction, et les nodules forment des images d'additions sur un cliché de lavement baryté.

e. L'épaississement pariétal se manifeste par un rétrécissement sur un cliché de lavement baryté.

75-Le transit du grêle:

a. Est de plus en plus pratiqué vu la non disponibilité de l'imagerie en coupes.

b. Un cliché d'abdomen sans préparation (ASP) est réalisé en premier temps

c. Consiste à réaliser une opacification par le Sulfate de baryum.

d. Consiste à réaliser une opacification par du Mannitol.

e. Permet une étude de la paroi et de l'environnement des intestins.

76-Concernant l'occlusion intestinale aiguë du grêle, la TDM montre :

a. Des anses grêles dilatées en amont de la zone de transition.

b. Des anses grêles collabées en amont de la zone de transition.

c. Distension colique.

d. Permet l'identification d'une souffrance intestinale.

e. Permet l'identification de la zone de transition et l'étiologie.

77-La technique d'examen d'abdomen sans préparation (ASP) nous permet de rechercher (cochez les bonnes réponses) :

a. Les opacités anormales notamment le pneumopéritoine.

b. Des signes d'occlusion, dont : les niveaux hydro aériques centraux plus larges que hauts témoignent d'une occlusion grêlique, et les niveaux périphériques plus hauts que larges témoignent d'une occlusion colique.

c. Les corps étrangers radio opaques.

- d. Le pneumo r trop ritoine qui est un croissant radio-transparent sous une ou les deux coupole(s).
- e. L'hypertrophie d'un organe (h patom galie ou spl nom galie) qui se manifeste par une opacit  anormale.

78-Concernant Les techniques d'opacification digestive, cochez les assertions justes :

- a. L'opacification am liore l'analyse du contenu des organes creux en  tudiant le liser  muqueux, le volume et la forme des organes, la r gularit  de leurs parois.
- b. L'opacification digestive permet une  tude morphologique et fonctionnelle.
- c. Le TOGD conserve des indications ponctuelles, car l'imagerie en coupes ne remplace pas totalement les informations anatomiques globales qu'il peut fournir.
- d. Le transit du gr le est largement remplac  par le colo scanner.
- e. Le produit de contraste utilis  pour les opacifications n'est pas radio opaque.

79-L' chographie est un examen de premi re intention pour l'exploration de l'appareil digestif, cochez les propositions justes concernant sa technique et ses r sultats :

- a. Permet d'explorer l'abdomen en temps r el.
- b. Permet d'explorer   la fois les organes pleins, les voies biliaires et le tube digestif.
- c. Le kyste se manifeste par une image hyper chog ne r fl chissant les ultrasons et s'accompagne d'un c ne d'ombre.
- d. Les lithiases sont des images an chog nes avec renforcement post rieur
- e. Le surpoids du patient, les structures osseuses ou qui contiennent de l'air, sont les principales limites de l'exploration  chographique.

80-L'imagerie moderne et la radiologie interventionnelle ont pris une place pr pond rante dans l'exploration et le traitement des pathologies digestives, choisissez les bonnes r ponses concernant leurs techniques et r sultats :

- a. La s miologie tomodensitom trique est fond e sur les quatre densit s fondamentales : a rique, hydrique, graisseuse et calcique.
- b. Le Mannitol est le produit de contraste utilis  en injection IV   la TDM et l'IRM.
- c. L'ent ro scanner et l'ent ro IRM ne n cessitent pas une pr paration et un remplissage intestinal pr alable.
- d. La radiologie interventionnelle peut se faire sous guidage  chographique, fluoroscopique ou scanographique
- e. La radiologie interventionnelle a des indications multiples, notamment les biopsies abdominales, ponction-drainage des abc s abdominaux et le drainage biliaire.



Département de Médecine de Constantine-Epreuve de SEMILOGIE(UNITE DIGESTIVE)-A3- le 15-06-2026

Page 1/1

Date de l'épreuve : 10/06/2026

Corrigé Type

Barème par question : 0.250000

N°	Rép./Alternatives 1&2		
1	D		
2	BC		
3	AC		
4	ABD		
5	BCD		
6	ACDE		
7	BE		
8	ABCE		
9	CD		
10	BC		
11	BC		
12	ABCD		
13	AD		
14	AD	D	
15	ABCDE		
16	ABE		
17	ABE		
18	BCE		
19	ADE		
20	AC		
21	BC		
22	A		
23	C		
24	ABC		
25	DE		
26	B		
27	ABCD		
28	ABCE		
29	CD		
30	ACDE		
31	ACDE		
32	B		
33	E		
34	CE		
35	ABC		

N°	Rép./Alternatives 1&2		
36	BCD		
37	ABD		
38	ABC		
39	ADE		
40	ACE		
41	BC		
42	ABD		
43	BD		
44	BC		
45	CDE		
46	BD		
47	CDE		
48	C		
49	C		
50	BE		
51	BCDE		
52	B		
53	C		
54	B		
55	C		
56	E		
57	C		
58	BCD		
59	A		
60	C		
61	B		
62	D		
63	ACD		
64	B		
65	D		
66	A		
67	ACE		
68	A		
69	ABCD		
70	ABDE		

N°	Rép./Alternatives 1&2		
71	ADE		
72	ABE		
73	AE		
74	ACE		
75	BC		
76	ADE		
77	BCE		
78	ABC		
79	ABE		
80	ADE		

Pr. Houss BENABDERRAHMANE
Maître de Conférences A
Service de Médecine Interne
CHU CONSTANTINE
N° Carte : 575